Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	FERNANDA MARIANA DIAZ LAGOS				Sexo	F X	M
Fecha Nacimiento	09-11-2015	Edad actual	10 años	6 meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	CALLE NUEVA # 1531				Teléfono	98202753	
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☑				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☐ lee ☑ escribe ☑				
Escolaridad actual:	5° BASICO	Establecimiento	Liceo mixto Los Andes				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 02-04-26	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Pamela LAGOS Olmedo	Nombre:
Relación con el/la estudiante: MADRE	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 02-04-26	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Silvana Magna	Nombre:
Rol/cargo: Educadora Diferencial	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Ingreso a PIE

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☑ Sí (especificar) TEA Nivel I

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009

Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Genético:	Psicopedagogia:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional: Antonia SALINAS
Neurología: Dr. Mauricio Lopez	Otro:

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☑ cesárea (señalar motivo) PROGRAMADA, Cordón enredado

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☒ SI ☐ NO | Peso: | Talla:

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

Sin Antecedentes Mórbidos

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	(No)	Traumatismos	Sí	(No)	Encefalitis	Sí	(No)
Obesidad	Sí	(No)	Intoxicación	Sí	(No)	Meningitis	Sí	(No)
Fiebre alta	Sí	(No)	Enfermedad respiratoria	Sí	(No)	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	(No)	Asma	Sí	(No)			
Hospitalizaciones	Sí	(No)	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud (Sí) No | Vacunas (Sí) No

Observaciones:

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 3 meses	Se sienta sólo/a: 6 meses	Camina sin apoyo: 1 año 2 meses
Primeras palabras:	Primeras frases:	Se viste solo/a: 2 años

Controla esfinter vesical Diurno: X Nocturno: X 2 1/2 años

Controla esfinter anal Diurno: X Nocturno: X 3 1/2 años

Observaciones:

En su actividad motora general se aprecia: ☐ normal ☒ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia: ☒ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	(Sí)	No	Caídas frecuentes	Sí	(No)	Dominancia lateral	(Sí)	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	(Sí)	No	Prensión	(Sí)	No	Pinza	(Sí)	No
Ensarta	(Sí)	No	Dibuja	(Sí)	No	Escribe	(Sí)	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	(Sí)	No	Manipula y Explora objetos	(Sí)	No

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA

Demanda objetos y compañía

Sonríe, balbucea, grita, llora,

Observaciones: en que desde Vestibulon Control pos

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos formas, movimientos, etc.)

En ocasiones tiene los ojos i

Presenta dolores frecuentes

Se acerca o aleja demasiad vista (frunce el ceño)

Sigue con la vista el despla objetos o personas

Presenta movimientos ocul

Manifiesta conductas "erró choques)

Presenta diagnóstico médi estrabismo, astigmatismo,

Observaciones: En ocasio puertas

5.4. Desarrollo del Leng

El niño (a) se comunica

☐ oral ☐ gestual ☑ mi

Características del lengu

Balbucea (oral o señas)/e

Vocaliza/realiza gestos o

Emite palabras/produce s

Características del leng

Identifica objetos

Identifica personas

Comprende conceptos al

Responde en forma cohe la vida diaria

Manifestó pérdida del le

Observaciones:

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáne le su entorno natural.

LOS DATOS CONTENI

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Demanda objetos y compañía	(Sí)	No	Comprende prohibiciones	(Sí)	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	(Sí)	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Sí	(No)

Observaciones: en terapia ocupacional me indicaron que debe ser favorecida la integración Vestibular y Propioceptiva para mejorar el Control postural y la organización Corporal.

5.3. Visión - Audición:					
Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	(Sí)	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	(Sí)	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	(No)	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	(Sí)	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	(No)	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	(Sí)	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	(No)	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	(No)
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	(Sí)	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	(Sí)	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	(No)	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	(No)
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	(Sí)	No	La pronunciación oral es adecuada	(Sí)	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	(No)	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	(No)

Observaciones:
En ocasiones choca con los bordes de la puertas.

5.4. Desarrollo del Lenguaje					
El niño (a) se comunica preferentemente en forma ☐ oral ☐ gestual ☑ mixto ☐ otro (especifique):					
Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	(Sí)	No	Emite/produce frases	(Sí)	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	(Sí)	No	Relata experiencias	(Sí)	No
Emite palabras/produce señas	(Sí)	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	(Sí)	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	(Sí)	No	Sigue instrucciones simples	(Sí)	No
Identifica personas	(Sí)	No	Sigue instrucciones complejas	(Sí)	No
Comprende conceptos abstractos	(Sí)	No	Sigue instrucciones grupales	(Sí)	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	(Sí)	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	(Sí)	No
Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):					
Observaciones:					

5.5. Desarrollo Social					
Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	(Sí)	No	Se relaciona en forma colaborativa	(Sí)	No

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Explica razones de sus comportamientos y actitudes	(Sí)	No	Respeta normas sociales	(Sí)	No
Participa en actividades grupales	(Sí)	No	Respeta normas escolares	(Sí)	No
Opta por trabajo individual	Sí	(No)	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	(No)	Movimientos estereotipados	(Sí)	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	(Sí)	No	Pataletas frecuentes	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
☑ natural ☐ desmesurada	☑ natural ☐ desmesurada	☑ natural ☐ desmesurada

Observaciones: Le molesta el sonido del refrigerador

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	(Sí)	No	Trastorno motor	Sí	(No)
Epilepsia	Sí	(No)	Problema bronco-respiratorio	Sí	(No)
Problemas cardiacos	Sí	(No)	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	(No)
Paraplejia	Sí	(No)	Trastorno emocional	Sí	(No)
Pérdida auditiva	Sí	(No)	Trastorno conductual	(Sí)	No
Pérdida visual	Sí	(No)	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):
TEA Nivel I = 1 vez en la mañana Azymol 10mg –

Alimentación: ☑ normal ☐ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☑ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 8 horas

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☒ despierta de buen humor

Duerme: ☒ solo ☐ acompañado
(Especifique): A veces se PASA A LA CAMA de los PADRES.

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

☒ alegre ☐ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)

Otro: No comprende mucho las bromas.

Observaciones:
– LE molesta que LAS personas se hablen AL oído ya que piensa que hablan de ella. (Esto lo hacían reiteradamente sus compañeros en el colegio anterior, lo que provocaba desregulaciones).

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. PAMELA LAGOS O.	MADRE	47	UNIVERSITARIA	Enfermera
2. Juan Carlos DIAZ	PADRE	51	UNIVERSITARIA	Ing. Civil Indus
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Antecedentes de Salud de la Familia
(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):
- Hermano Juan Pablo 12 años + DAH en tratamiento. - Padres sin antecedentes mórbidos.
Observaciones:

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar					
Edad de ingreso al sistema escolar	5 años	Asistió a jardín infantil		Sí	(No)
N° de colegios en que ha estudiado	1	Modalidad de enseñanza Regular (X) Especial ☐ Técnica ☐:			
Motivo de los cambios: Hostigamiento reiterado (Bullying)					
Ha repetido curso/s	Sí (No)	Curso(s)	Motivo:		

Por Ajuste de mecanismos y Cambio Colegio

Situación actual												
Nivel/curso actual	5°		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	(No)	**Dificultad para participar**	Sí	(No)	**Conducta disruptiva**	(Sí)	No
Asiste regularmente	(Sí)	No	Asiste con agrado	(Sí)	No	Apoyo familiar en tareas	(Sí)	No	Amigos (as)	(Sí)	No

Actitud de la familia
¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante? ☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....
¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante? ☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....
¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante? ☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra ..... Especifique el tipo de refuerzos o premios: ☑ expresiones afectivas ☑ alimentos preferidos ☐ ver TV ☑ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....
¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante? ☑ madre ☑ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....
¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante? ☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)
¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje? ☑ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

5

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

En Abril Fernanda ingreso al liceo mixto, lopó istos 2días y tuvo una desregulación severa. Fue evaluada por Neurólogo quien indico reposo en casa hasta la primera semana de mayo, ajusto medicamentos y retor no al Liceo el 11/05 con jornada reducida.